



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سحر علي سيد حسن
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الخليفة
رقم البطاقة : 26701120101206 رقم التليفون : 01067113439
العنوان : الحليمه
العمر (تاريخ الميلاد) : 12-01-1967 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص
مدير عام
مديرية الشؤون الصحية
ختم
شعار الجمهورية

--

Name: سحر علي سيد حسن National ID: 26701120101206	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



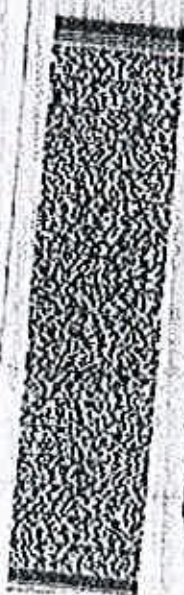
محمد بن عبد الله
مدير عام
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض - ١١٥٥

KT3657550

٢٠١٧ - ٠١ - ١٢ - ٠١ - ٠١ - ٠١



محمد بن عبد الله
مدير عام
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض - ١١٥٥



Patient Name : الأستاذة / سحر على سيد حسن
 Patient No. : 26701120101206
 Path No. : 2104/23
 Sex : Female
 Age : 53 Y
 Referring Doc. :

Request No. : 13007950
 Request Date : 06/07/2023
 Verification Date : 10/07/2023
 Referral Category : Out Patient
 Department :
 IHC No. :
 Registered by : marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, core.

Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 1cm, totally submitted.

Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

Histological type: Invasive duct carcinoma.

Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+1) Grade II.

Ductal carcinoma in situ: No.

Perineural invasion: No.

Angiolymphovascular invasion: No.

IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (All cases score 8/8).

PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (All cases score 8/8).

Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0/3+).

Ki67: 15% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

invasive duct carcinoma GII with focal microcapillary features.

IHC:

ER: Positive (score 8/8).

PR: Positive (score 8/8).

Verified by :

DR.Menna Nabil

Name: سحر علي سيد			
MR. : 3679			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient was diagnosed in 2023 with an upper front left breast carcinoma treated by mastectomy (LT MRM) staged as T2 N3 M0. Adjuvant therapy was initiated, including AC chemotherapy for four cycles, followed by TXT for four cycles, radiation therapy (PORTH), aromatase inhibitor (AI), and zoledronic acid (ZOMETA). On the day of the note, the patient received femara (letrozole) and continued zoledronic acid. The patient remains on adjuvant femara, which was started in July 2024. A recent CT of the chest, abdomen, and pelvis was performed, and the plan is to continue femara for an additional three months.			
تحريراً في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :		نهى سعيد علي محمد	
الطبيب المعالج :			
يعتمد ,			

Patient Name	: الأمثلة / ماهر علي سيد حسن	Request No.	: 13007944
Patient No.	: 26701120101206	Request Date	: 18/09/2023
Path No.	: 3156/23	Verification Date	: 01/10/2023
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اوراد دار السلام
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Up-Front

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Left MRM measured 23x13x4 cm with covering skin ellipse measured 8x5x2 cm.
- * Tumor extent: multiple ill defined greyish white firm masses.
- * The 1st mass measured 2.5x1.8x1.5 cm at (IUQ), away 0.5 cm from skin and 3cm from deep margin.
- * The 2nd mass measured 1x0.7x0.3 cm and 2.5 cm away from the 1st mass.
- * The 3rd mass measured 1x0.5x0.5 cm (nearest to skin 0.2cm).
- * The 4th mass measured 0.5x0.5x0.5 cm.
- * The 5th mass measured 1x0.5x0.5 cm (nearest to deep margin 2 cm) and away 2 cm from the 1st mass.
- * The 6th mass measured 0.7x0.5x0.5 cm.
- * Rest of breast showed grayish white rubbery scattered areas.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Lymph nodes number and size: Axilla measured 8x5x2 cm entangling 15L.Ns up to 0.5x0.5cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Multicentric invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: minimal 5%.
- * Lymphovascular emboli: occasional.
- * Perineural invasion: Positive.
- * Skin involvement: Infiltrating the dermis of the skin with free epidermis. Free nipple and areola.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 07/10/2023 12:05:58

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

A-Patient ID:
1- Name: **مريم علي بن محمد**
2- ID number: **25701120101205**

MDT form
3- Medical number:
female
Date: **11/10/2023**

53154482
Old Med:
2503-2023

Family history: **Family history -VE**
Phone: **01067113439**
BMI: **24**
Marital status: **Married**
HRS Score: **0100679154**
GROUP: **1**
Comorbidity: **DM, HTN**
Menopausal status: **Postmenopausal**

REASON OF MDT:
Date of MDT:

Breast Imaging:

Clinical data

BX: IDC	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu: 0	SISH: 0	HER2: 1A
TCAP: Free	TCAP: Free	TCAP: Free	TCAP: Free	TCAP: Free	TCAP: Free

T 2	N 3(11/15)	M 0
--------	---------------	--------

Sonomammography

CESM : LT Breast multiple malignant masses + LT Indeterminate L.N.S

PATIENT HISTORY

UPFRONT LT MRM:
free margins
LH 11/15 extra cap. extension
lymph vas, emboli +ve perineural invasion

MDT OUTCOME & PLAN

FULL LABS, ECHO, START ADJUVANT AC X 4 THEN TAXOTERE X4 THEN PORT, THEN ADJUVANT AT COMBINED WITH PROPHYLACTIC ZOMETA EVERY 6 MONTHS

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	<i>[Signature]</i>	RADIOLOGY	<i>[Signature]</i>
SURGERY	<i>[Signature]</i>	PATHOLOGY	<i>[Signature]</i>
Psychiatric	<i>[Signature]</i>	NUTRITION	<i>[Signature]</i>

Name: Mrs. Sahar Ali Sayed Hassan

Date: 8/8/2023

ID:2222029943

Acc.:4824962

Tc-99m MDP whole body bone scan

Technique:

- Whole body images were acquired 180 minutes after IV injection of ~15 mCi of the tracer.

Findings:

- Uniform tracer uptake all over the surveyed skeleton is noted with no evidence of any active spots.
- Degenerative changes of the spine are seen.
- Arthritic knee changes are noted.
- Both kidneys are visualized.

Opinion:

- No scintigraphic evidence of metastatic osseous deposits.

Truly yours

Prof. Dr. Ahmed Kandeel. MD

Prof. of Nuclear Medicine, faculty of medicine, Cairo University

Patient Name : الأمل / سحر على سيد حسن
Patient No. : 26701120101206
Path No. : 3155/23
Sex : Female
Age : 56 Y
Referring Doc :

Request No. : 13007944
Request Date : 18/09/2023
Verification Date : 01/10/2023
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Up-Front

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Left MRM measured 23x13x4 cm with covering skin ellipse measured 3x5x2 cm.
- * Tumor extent: multiple ill defined greyish white firm masses.
- * The 1st mass measured 2.5x1.8x1.5 cm at (IUQ), away 0.5 cm from skin and 3cm from deep margin.
- * The 2nd mass measured 1x0.7x0.3 cm and 2.5 cm away from the 1st mass.
- * The 3rd mass measured 1x0.5x0.5 cm (nearest to skin 0.2cm).
- * The 4th mass measured 0.5x0.5x0.5 cm.
- * The 5th mass measured 1x0.5x0.5 cm (nearest to deep margin 2 cm) and away 2 cm from the 1st mass.
- * The 6th mass measured 0.7x0.5x0.5 cm.
- * Rest of breast showed grayish white rubbery scattered areas.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Lymph nodes number and size: Axilla measured 8x5x2 cm entangling 15L.Ns up to 0.5x0.5cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Multicentric invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: minimal 5%.
- * Lymphovascular emboli: occasional.
- * Perineural invasion: Positive.
- * Skin involvement: Infiltrating the dermis of the skin with free epidermis.
Free nipple and areola.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Print Date : 07/10/2023 12:05:58

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name: الأستاذة / منى محمد
Patient No.: 26701120101206
Path No.: 3156/23
Sex: Female
Age: 56 Y
Referring Doc:

Request No.: 13007944
Request Date: 18/09/2023
Verification Date: 01/10/2023
Financial Category: نفقة الدولة
Department: Out Patient
Registered by: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- * Lymph node involvement: positive in (11/15) with extracapsular extension.
- * Resection Margins: Free deep margin.
- * Additional pathologic findings: N/A.

Diagnosis:

- Left breast cancer, MRM specimen:
- * Multicentric Invasive duct carcinoma G II with minimal DCIS 5%.
- * Occasional lymphovascular emboli.
- * Positive perineural invasion.
- * The tumour infiltrate the dermis of the skin with free epidermis.
- * Free nipple and areola.
- * Lymph node were positive in (11/15) with extracapsular extension.
- * Free deep margin.
- * Stage: pT2, N1.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Menna Nabil.

Verified by:
DR. Menna Nabil

Printing Date: 07/10/2023 12:05:58

Page 2 of 2

Printing By: .marwa mohamed youss

Name: Mrs. Sahar Ali Sayed Hassan

Date: 30/7/2023

ID:2222029943

Acc:14821584

Referring Prof. Dr. Mohamed Kadry Shalaby

MSCT scan of the chest, abdomen and pelvis with oral & IV contrast, revealed:

Clinical history: left breast lump.

Chest

- Left breast multiple irregular enhancing soft tissue lesions, the largest at UIQ measuring about 2.2 x 2.5 cm.
- Few prominent left axillary level I lymph nodes, the largest measuring about 0.8 x 1.2 cm.
- No sizable pulmonary nodules, no pulmonary masses, calcifications or cavitations.
- No pleural or pericardial collection.
- No abnormal hilar or mediastinal masses or enlarged lymph glands.
- The heart and great vessels appear normal.

Abdomen and pelvis

- Normal size of the liver with homogenous parenchymal texture. No hepatic focal lesions or biliary tree dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas and both supra renals.
- Both kidneys are seen in position and normal in size. No renal masses, stones or back-pressure changes.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodal enlargement.
- No ascites.

PATIENT NAME: SAHAR ALI SAYED HASSAN
GENDER: Female
AGE: 56 y

PATIENT ID #: 10123229916
ORDER #: 2423287,2424153
DATE OF SERVICE: 06-Aug-2023 12:17 PM

Report: - all studies

**CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY, 3D
DIGITAL TOMOSYNTHESIS, AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

INDICATION:

- Check-up.

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO view.,
- Complementary ultrasound

REPORT:

- - Scattered fibroglandular densities (ACR b).

The right breast :

- - No spiculated mass lesions or microcalcific clusters.
- - Contrast Enhanced Spectral Mammography showed mild back ground parenchymal enhancement with no significant enhancing lesions.
- No solid or cystic lesions by US
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific axillary lymphadenopathy.

The left breast :

- UIQ Multiple spiculated hyperdense mass enhancing lesions are seen extending over an area that measures about 10.3x8.6cm in MLO view. Associated multiple segmental pleomorphic calcifications.
- By US multiple spiculated hypoechoic lesions with desmoplastic reaction are seen extending from 9 to 1 o'clock position. The largest lesion seen measuring 2.3x1.8cm. It shows internal vascularity.
- The nearest lesion to the nipple seen at 1 o'clock about 1.7 cm distant. The nearest lesion to the skin seen at 9 o'clock about 5mm deep to skin.
- UOQ focal asymmetry with no related enhancing lesions or pathological microcalcifications; corresponds by US to an area of focal glandular condensation with no solid lesions.
- Normal skin thickness and contour.

- Normal nipple areola complexes.
- Few (2-3) left axillary lymph nodes showing mild cortical thickening reaching 4 mm and effaced fatty hilum . The largest one measures 1.2 cm.
- Clear supraclavicular regions bilaterally.

OPINION:

- Left breast multiple malignant looking mass lesions associate with UOQ segmental pathological microcalcifications (BIRADS 5); For correlation with histopathological findings.
- Left axillary indeterminate lymph nodes.

Recommendation - all studies

Reported By,

Dr. Ghada Ali, MSc

06-Aug-2023 01:49 PM



النقابة العامة للمحامين
مشروع الرعاية الصحية
للمحامين وأسرهم

شهادة

تشهد النقابة العامة للمحامين بأن الأستاذة / سحر على سيد حسن المحامية
المقيدة تحت رقم / 202411
غير مشتركة بمشروع العلاج بالنقابة العامة للمحامين ولم يتم الاستفادة منه لهذا
العام 2026.

وذلك

لتقديمها لأي جهة يرغب بها دون أدنى مسئولية على النقابة العامة للمحامين .

عضو المجلس

التوقيع /

التاريخ / 2026/2/22



صيدلية
د. عادل الميري
25747903

مستشفيات صحة
العقاد - الجيزة
Hotline: 15485

معامل
ميترا
METRA LABORATORIES
دقة نتحقق الثقة



تجاربنا وأشعة في مكان واحد
البراج
(1991)

المختبر
19014



النقابة العامة للمحامين
مشروع الرعاية الصحية
للمحامين وأسرهم

شهادة

تشهد النقابة العامة للمحامين بأن الأستاذة / سحر على سيد حسن المحامية
المقيدة تحت رقم / 202411
غير مشتركة بمشروع العلاج بالنقابة العامة للمحامين ولم يتم الاستفادة منه لهذا
العام 2026.

وذلك

لتقديمها لأي جهة يرغب بها دون أدنى مسئولية على النقابة العامة للمحامين .

عضو المجلس

التوقيع /

التاريخ / 2026/2/22



صيدلية
د. عادل الميري
25747903

مستشفيات صحة
العقاد - الجيزة
Hotline: 15485

معامل
ميترا
METRA LABORATORIES
دقة نتحقق الثقة



تجاربنا وأشعة في مكان واحد
البرج
1991

المختبر
19014



النقابة العامة للمحامين
مشروع الرعاية الصحية
للمحامين وأسرهم

شهادة

تشهد النقابة العامة للمحامين بأن الأستاذة / سحر على سيد حسن المحامية
المقيدة تحت رقم / 202411
غير مشتركة بمشروع العلاج بالنقابة العامة للمحامين ولم يتم الاستفادة منه لهذا
العام 2026.

وذلك

لتقديمها لأي جهة يرغب بها دون أدنى مسئولية على النقابة العامة للمحامين .

عضو المجلس

التوقيع /

التاريخ / 2026/2/22



صيدلية
د. عادل الميري
25747903

مستشفيات صحة
العقاد - الجيزة
Hotline: 15485

معامل
ميترا
METRA LABORATORIES
دقة نتحقق الثقة



تجاربنا وأشعة في مكان واحد
البراق
(1991)

المختبر
19014







٢٠٣٤/٠٩

٢٦٧٠١٦٢٠١٠٢٠٦

٢٠٣١/٠٩/١٨

مقاطعة غزة

انثى

مسن احمد سعيد السنيانطي

مطلوبة

مطلوبة

البطاقة سارية حتى